

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

HCR-20 v3 · GUÍA DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO DE VIOLENCIA

Historical-Clinical-Risk Management-20 (Version 3) – Estándar internacional de juicio profesional estructurado (SPJ)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial	Historical-Clinical-Risk Management-20, Version 3 (HCR-20 v3)
Autores Originales	Kevin S. Douglas, Christopher D. Webster, Stephen D. Hart, Randall T. Otto y Christopher Belfrage (2013)
Adaptación Española	Karin Arbach-Lucioni, Antonio Andrés-Pueyo et al. (2015)
Tipo de Instrumento	Guía estructurada de juicio profesional asistido (Structured Professional Judgment - SPJ)
Población Diana	Adultos (>= 18 años) en contextos psiquiátrico-forenses, penitenciarios y salud mental comunitaria
Tiempo de Aplicación	1.5 a 3 horas (revisión documental exhaustiva, entrevista clínica y contraste con informantes)
Formato de Valoración	Evaluación triple: Presencia del factor (No / Posible / Sí) y Relevancia clínica para la violencia futura (Baja / Media / Alta)
Finalidad Clínica	Predicción del riesgo de violencia física grave contra terceros, diseño de planes individualizados de gestión del riesgo y toma de decisiones sobre permisos penitenciarios o altas hospitalarias

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

La predicción de la conducta violenta en psiquiatría y psicología jurídica evolucionó desde el juicio clínico intuitivo no estructurado (altamente subjetivo e inexacto) hacia las herramientas actuariales puras (rígidas y carentes de utilidad terapéutica dinámica). El modelo de Juicio Profesional Estructurado (SPJ), del cual el HCR-20 es el paradigma mundial de referencia, sintetiza lo mejor de ambos mundos: protocoliza la recopilación sistemática de factores de riesgo empíricamente demostrados, pero deja la estimación final y el plan preventivo en manos del criterio clínico razonado.

El HCR-20 v3 estructura la violencia a través del tiempo en tres dimensiones operacionales: a) **Factores Históricos (H)**, que representan rasgos y sucesos del pasado estáticos o cuasi-estáticos; b) **Factores Clínicos (C)**, que capturan el estado psicopatológico dinámico actual y reciente (últimos 6 meses); y c) **Factores de Gestión del Riesgo (R)**, que proyectan la vulnerabilidad del sujeto ante los escenarios futuros comunitarios o institucionales previstos. La versión 3 introduce de forma revolucionaria la distinción entre la **mera presencia** del factor y su **relevancia causal** en el caso individual.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Escala Temporal	Nº Ítems	Factores Evaluados y Contenido Forense Específico
Factores Históricos (H)	10 ítems	H1 Violencia previa, H2 Otra conducta antisocial, H3 Relaciones de pareja, H4 Empleo, H5 Consumo de sustancias, H6 Trastorno mental grave, H7 Trastorno de personalidad, H8 Experiencias traumáticas, H9 Actitudes violentas, H10 Fracaso en supervisión previa.
Factores Clínicos (C)	5 ítems	C1 Conciencia de enfermedad e insight, C2 Sintomatología psicótica activa, C3 Inestabilidad afectiva, C4 Impulsividad conductual, C5 Falta de adherencia al tratamiento.
Gestión del Riesgo (R)	5 ítems	R1 Planes realistas de futuro, R2 Red de apoyo social/familiar, R3 Estrés psicosocial previsto, R4 Disponibilidad de sustancias/armas, R5 Cumplimiento de la supervisión.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMACIÓN Y REGLAS DE CORRECCIÓN · HCR-20 v3

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATINOAMÉRICA

Fiabilidad Inter-Jueces	Coefficiente de correlación intraclase (ICC) = 0.86 a 0.93 en valoraciones forenses y penitenciarias en España (Arbach-Lucioni et al., 2015). En la estimación global del riesgo el ICC alcanza 0.88.
Validez Predictiva (ROC)	Área Bajo la Curva ROC (AUC) para reincidencia violenta física a 1-3 años oscila entre 0.76 y 0.84, situándolo como el instrumento con mayor exactitud predictiva en psiquiatría legal.
Validez Concurrente	Elevada correlación con la escala de psicopatía de Hare (PCL-R, $r = 0.68$) y con la Violence Risk Appraisal Guide (VRAG, $r = 0.72$).
Utilidad Preventiva	Eficacia clínica demostrada en la reducción de incidentes agresivos intrahospitalarios mediante la formulación dinámica de planes de gestión de riesgo personalizados.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

- Codificación de la Presencia (0, 1 o 2):**
 - 0 (No):** El factor está ausente o no existe evidencia creíble de su ocurrencia.
 - 1 (Posible / Parcial):** Evidencia incompleta o manifestación en grado moderado.
 - 2 (Sí):** Evidencia clara y suficiente de presencia inequívoca del factor.
- Codificación de la Relevancia:** Para cada factor codificado con 1 o 2, el clínico debe determinar si dicho ítem es **Relevante** para el riesgo de violencia futura del sujeto (No / Posible / Sí).
- No es una escala puramente numérica sumatoria:** Aunque puede computarse una suma numérica (0 a 40 puntos) con fines de investigación, el SPJ exige una **Estimación del Juicio Profesional Conclusivo** en tres niveles: **Bajo, Medio o Alto**.
- Formulación del Caso:** Construcción narrativa de los escenarios plausibles de violencia (quién sería la víctima, bajo qué disparadores, con qué grado de letalidad y qué medidas de contención son necesarias).

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Nivel de Riesgo SPJ	Suma HCR Aprox.	Probabilidad Violencia	Directriz Asistencial, Penitenciaria y Legal
Riesgo Bajo	0 a 14 puntos	Baja (< 10%)	Supervisión rutinaria; no requiere medidas extraordinarias de contención.
Riesgo Medio	15 a 24 puntos	Intermedia (25-35%)	Plan de intervención activo; control de tóxicos y seguimiento ambulatorio.
Riesgo Alto	25 a 40 puntos	Muy Alta (> 60%)	Vigilancia intensiva; medidas de seguridad institucional o denegación de permisos.

PRINCIPIO LEGAL DEL JUICIO PROFESIONAL ESTRUCTURADO: El HCR-20 v3 prohíbe emitir decisiones forenses automáticas basadas en la suma matemática de puntos. Un paciente con sólo 2 factores presentes pero de extrema relevancia letal (p. ej., delirio persecutorio no tratado focalizado en su expareja más acceso a armas de fuego) debe ser clasificado en RIESGO ALTO.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y DIRECTRICES · HCR-20 v3

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN

Paso 1: Recopilación Multifuente: Contrastar el expediente penal, antecedentes psiquiátricos históricos y conducta en el módulo/sala con entrevista personal.

Paso 2: Evaluación de Presencia y Relevancia Causal de los 20 Factores.

Paso 3: Formulación de Escenarios y Gestión del Riesgo (RMP):

- **Escenario de Riesgo Alto:** Descompensación psicótica activa combinada con consumo de tóxicos.
- **Medidas de Prevención Específicas:** Tratamiento antipsicótico depot supervisado (LAI), controles toxicológicos bisemanales en orina, prohibición judicial de aproximación y coordinación con servicios sociales.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO (VIGNETTE)

Identificación: Varón de 33 años internado en Hospital Psiquiátrico Penitenciario tras homicidio en grado de tentativa contra un vecino bajo delirio paranoide. Se evalúa solicitud de permiso de salida de fin de semana.

Evaluación HCR-20 v3:

- **Factores Históricos (H):** 16 / 20 puntos. Historial de violencia física grave (H1 = 2), inicio temprano de consumo de cannabis y cocaína (H5 = 2), esquizofrenia paranoide (H6 = 2) y abandono previo de tratamiento (H10 = 2).
- **Factores Clínicos (C):** 6 / 10 puntos. Insight parcial de la enfermedad (C1 = 1), ausencia de psicosis activa bajo medicación actual (C2 = 0), pero persistencia de impulsividad motora ante frustraciones menores (C4 = 2).
- **Gestión del Riesgo (R):** 8 / 10 puntos. Planes de futuro poco realistas (R1 = 2), convivencia en el mismo barrio donde residen los familiares de la víctima (R3 = 2) y alto riesgo de disponibilidad de sustancias ilícitas (R4 = 2).

Conclusión Forense: Aunque los síntomas psicóticos agudos están en remisión dentro del medio cerrado hospitalario, los factores de gestión del riesgo en la comunidad son muy desfavorables. Se emitió dictamen de Riesgo Alto de Violencia en caso de salida autónoma, denegándose el permiso individual y proponiéndose salidas terapéuticas programadas con estricta custodia y cambio previo de domicilio tutelado.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ALERTAS FORENSES Y DEONTOLÓGICAS

- La presencia de ideación u odio focalizado hacia una víctima específica concreta eleva el riesgo a inminente, con deber legal de advertencia y protección.
- La recaída en tóxicos desinhibidores anula de inmediato cualquier estabilización previa de los factores clínicos.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- **Violencia Instrumental vs Reactiva:** La violencia psicopática instrumental es fría y planificada, a diferencia de la agresión reactiva psicótica.
- **Simulación de Remisión:** Vigilancia ante aparente docilidad hospitalaria orientada a obtener el alta o beneficios penitenciarios.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

- Douglas, K. S., Hart, S. D., Webster, C. D., & Belfrage, H. (2013). *HCR-20V3: Assessing risk for violence (User guide)*. Mental Health, Law, and Policy Institute, Simon Fraser University.
- Arbach-Lucioni, K., Andrés-Pueyo, A., Pomarol-Clotet, E., & Gomar-Soley, J. (2015). Propiedades psicométricas de la versión española del HCR-20v3 en centros psiquiátricos penitenciarios. *Revista Española de Sanidad Penitenciaria*, 17(3), 80–89.
- Guy, L. S., Douglas, K. S., & Hendry, M. C. (2010). The role of risk and protective factors in predicting recidivism in a forensic psychiatric sample. *Law and Human Behavior*, 34(6), 498–511.
- Andrés-Pueyo, A., & Echeburúa, E. (2010). Valoración del riesgo de violencia: Instrumentos disponibles e indicaciones de aplicación. *Psicothema*, 22(3), 403–409.